

CHU RESANCON POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 1 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

+

1 – Concerne : le personnel médical et paramédical des urgences gynécologiques, de l'Hôpital de Jour de gynécologie et du service d'hospitalisation conventionnelle

2 – Application :

2.1 Définition

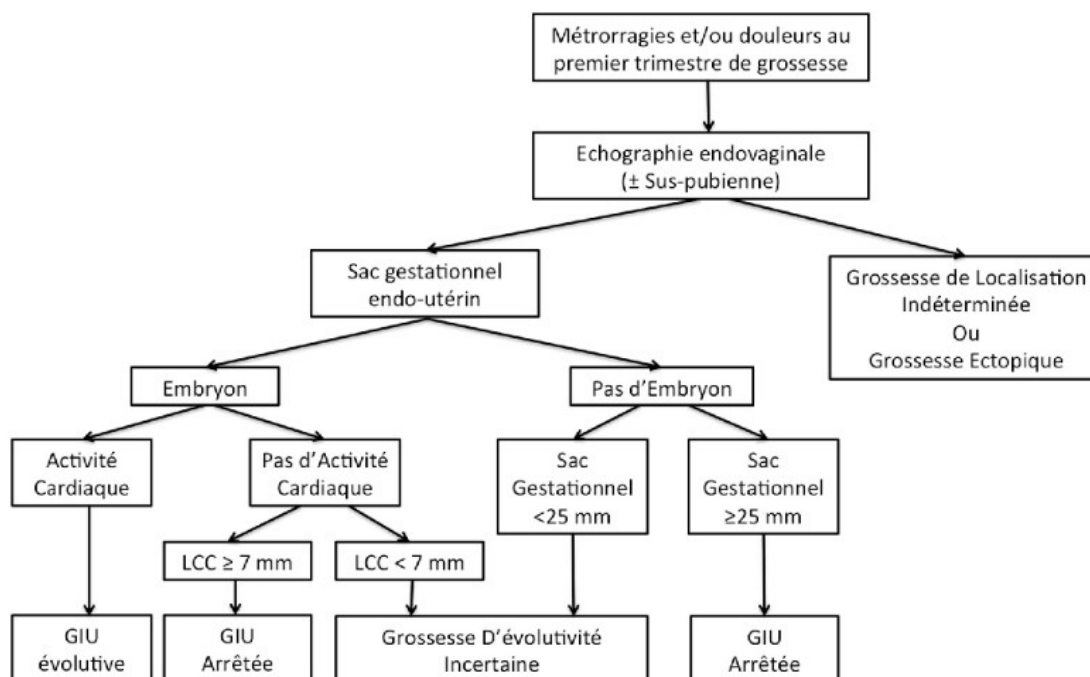
Une grossesse arrêtée précoce est un arrêt de développement (stagnation de la taille du sac gestationnel et/ou de la longueur cranio caudale et/ou une absence ou disparition d'une activité cardiaque) <14 SA

Pour rappel :

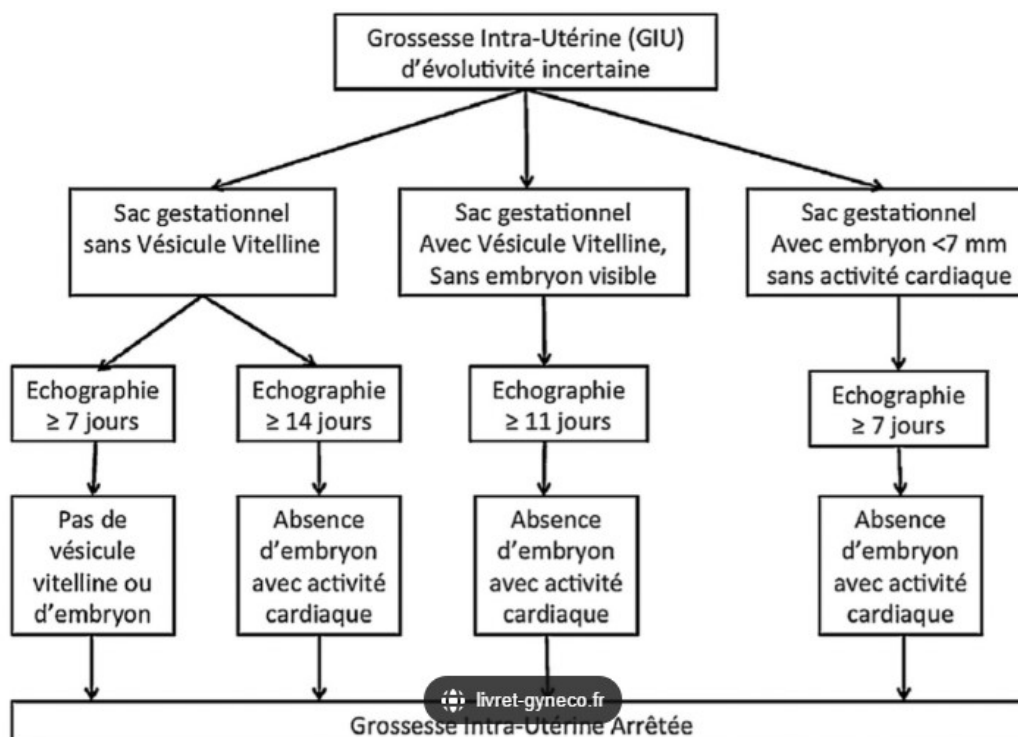
	10 SA	14 SA	22 SA	37 SA	Naissance
Absence d'activité cardiaque	Grossesse arrêtée		Mort fœtale in utéro		
Expulsion	Fausse couche précoce = Avortement spontané précoce	Fausse couche tardive = Avortement spontané tardif	Accouchement prématuré	Acc. à terme	
Contractions utérines modifications cervicales		Menace d'avortement spontané tardif	Menace d'accouchement prématuré	Mise en travail	
Nom du « bébé »	Embryon	Fœtus			Nouveau-né

Intitulé et référence du document associé : procédure grossesse et urgences gynécologique (090 URG 210 PC02 XXX)			
REDACTION : 06/11/2025 Dr Mégane ACHECHE Médecin Gynécologie-obstétrique Signé	VERIFICATION : 12/11/2025 Mohcine AICH Qualiticien - DAJPAQ Document signé	VALIDATION : 13/11/2025 Dr Romane BASSI Romane Médecin Gynécologie-obstétrique Dr Anne Sarah THOLOZAN-JUNIAT Médecin Gynécologie-obstétrique Signé	APPROBATION : 13/11/2025 Pr Nicolas MOTTET Chef de pôle mère-femme Signé
Liste de diffusion : urgences gynécologiques, HDJ de gynécologie via le logiciel institutionnel de gestion documentaire et le classeur virtuel de Gynécologie			
Relecture périodique du document - sans modification par : le :			

Conduite à tenir devant des métrorragies du premier trimestre :



Délais nécessaires pour affirmer une grossesse arrêtée en cas de grossesse d'évolutivité incertaine :



	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 3 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

2.2 Localisation de la grossesse

La localisation intra utérine de la grossesse est certaine.

Rappel : Tout SGIU (sac gestationnel intra utérin) avec au moins une vésicule vitelline définit une grossesse intra-utérine.



Il n'y a pas d'urgence à traiter une grossesse intra-utérine arrêtée sans association de signes cliniques de gravité !

En cas de suspicion de grossesse arrêtée, un rendez-vous de contrôle est proposé à la patiente avec un délai de minimum 7 jours avant décision d'un traitement médical.

Toute décision de prise en charge médicamenteuse ou chirurgicale d'une grossesse arrêtée doit être séniorisée.

2.3 Prévention de l'allo immunisation Rhésus D chez les patientes de groupe Rhésus D négatif.

Toute patiente enceinte doit avoir une carte de groupe sanguin valide.

Il est impératif de vérifier son rhésus, celui de son conjoint (et le génotypage s'il existe) afin de pouvoir réaliser une prophylaxie de l'allo immunisation rhésus si nécessaire.

→ Cf Protocole spécifique

3- Traitements

Toute prise en charge d'une GIU arrêtée doit être validée par le médecin sénior de garde.

Lorsque le diagnostic de grossesse intra-utérine arrêtée est certain, il peut être proposé à la patiente trois méthodes :

- **Attitude expectative**
- **Traitement médical**
- **Traitement chirurgical**

- 1) **Attitude expectative** : Un contrôle échographique est nécessaire au bout de 7 jours afin d'évaluer si l'avortement spontané a eu lieu. Il faut prévenir la patiente que cela peut prendre plusieurs jours voire quelques semaines avant que cela n'arrive. Si l'avortement spontané n'a pas eu lieu lors de la consultation de contrôle, il faut rediscuter les différents traitements qui s'offrent à elle.

 CHU RESANCON POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 4 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

2) **Traitement médical** : Proposé aux patientes < 11 SA

Il associe le traitement par Mifépristone (antagoniste de la progestérone) et 36 à 48 heures plus tard la prise de Misoprostol (analogue de la PGE1). En effet, la Mifépristone va potentialiser l'effet du Misoprostol.

3 Possibilités doivent être proposées à la patiente

- Prise de Misoprostol à la maison 36-48h après la prise aux urgences de Mifépristone le jour de la consultation (J0)
- Prise de Misoprostol en HDJ 36-48h après la prise aux urgences de Mifépristone le jour de la consultation (J0)
- Prise de Misoprostol en HDJ avec une date à convenir avec la patiente, mais cela oblige la patiente à revenir 36-48h avant son hospitalisation pour venir prendre le comprimé de Mifépristone

1 ère situation : Prise en charge à domicile souhaitée par la patiente :

DIAMM : Sortie 5.1 Grossesse arrêtée prise en charge médicale à domicile

La patiente doit habiter à moins de 30 minutes d'une structure hospitalière en raison du risque hémorragique. Elle doit avoir la capacité de comprendre comment se prend le traitement médical.

Il est important de réaliser un interrogatoire précis à la recherche de signes pouvant évoquer un trouble de la coagulation (ATCD hémorragiques de la patiente) contre indiquant le Misoprostol à domicile (cf Annexe)

○ Le schéma du **traitement** correspond à :

- J0 : Mifépristone 200 mg PO pris aux urgences
- J2 : Misoprostol 400 µg puis 400 µg 4h après en sublingual à domicile

Si absence d'expulsion de la grossesse reprendre un comprimé de Misoprostol 400 µg 4 heures après le 2^{ème} comprimé

Exemple de schéma thérapeutique :

J0 : Mifegyne

J2 : 8h : 1cp de Misoprostol

12h : 1 cp de Misoprostol

+/- 16h : 1 cp de Misoprostol si pas d'expulsion après les 2 premiers comprimés



Ne pas dépasser une dose totale de 1200 µg en 24h (soit 3 doses de 400 µg)

 CHU REIMS POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 5 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

- Un **traitement antalgique** adapté doit être systématiquement prescrit à la patiente (Ordonnance antalgiques protocolisée dans DIAMM)
- Un **arrêt de travail** doit également être systématiquement prescrit à la patiente (informée celle-ci de l'absence de délai de carence pour ce motif) jusqu'au prochain RDV de contrôle CERFA AT sans carence S3118 (Cf annexes)
- Un **livret d'information** doit être remis à la patiente
- La **délivrance des comprimés** de Misoprostol se fera aux urgences lors de la consultation. Il est obligatoire de rappeler à la patiente que la prescription est hors AMM, mais prescrit dans un cadre de DPC.
3 Cp seront délivrés avec comme consignes données aux patientes de ramener lors de leurs RDV de contrôle les comprimés restants.
- Tous les documents ainsi que les comprimés doivent être remis à la patiente dans le dossier dédié (Dossier que la patiente devra toujours ramener avec elle)
- Le **contrôle de la vacuité utérine** se fera dans le service de consultation post-urgence ou avec le praticien externe qui l'a adressé pour la prise en charge, à 7 jours environ de la prise des traitements pour une réévaluation clinique et échographique.
- En cas de persistance du sac gestationnel, discuter avec la patiente d'une deuxième cure de traitement ou d'une aspiration chirurgicale (à faire valider par médecin senior).
- A la fin du rendez-vous de contrôle de vacuité, une **nouvelle consultation** doit être proposée à la patiente, afin de répondre à ses questions, reprendre avec elle ce qu'elle vient de traverser, discuter de la suite, et proposer un bilan complémentaire dans le cadre des grossesses arrêtées à répétition DIAMM, Consultation, Dr Achèche M.

La patiente peut aussi prendre RDV ultérieurement en appelant le secrétariat au 03.81.21.81.20

RECOMMANDATION TEMPORAIRE D'UTILISATION (RTU)

PROTOCOLE DE SUIVI DES PATIENTES TRAITÉES PAR LE MISOPROSTOL ET LA MIFEPRISTONE DANS LA PRISE EN CHARGE DES GROSSESSES ARRÊTÉES AVANT 14 SA

En concertation avec les laboratoires concernés, l'ANSM a élaboré une RTU visant à sécuriser l'utilisation de la mifépristone et du misoprostol dans la prise en charge des grossesses arrêtées du premier trimestre (avant 14 SA). En effet, dans cette population non couverte par l'AMM et pour laquelle il existe un besoin thérapeutique, le rapport bénéfice/risque de la mifépristone et du misoprostol, est présumé favorable sur la base des données scientifiques d'efficacité et de sécurité disponibles (Février 2021)

Le traitement par mifépristone sensibilise le myomètre aux contractions induites par les prostaglandines et permet la dilatation et l'ouverture du col utérin. Le traitement par misoprostol induit des contractions utérines et permet l'ouverture du col afin d'accélérer l'expulsion du produit de conception ou du sac gestationnel (SG).

 CHU RESANCON POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 6 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

Outre le présent protocole, il est impératif que le médecin prescrivait du Misoprostol et de la Mifégyne dans le cadre de cette RTU prenne connaissance du résumé des caractéristiques du produit (RCP) notamment pour ce qui concerne les contre-indications, mises en garde, et effets indésirables.

Contre-indications à l'initiation d'un traitement par Misoprostol

- Hypersensibilité au misoprostol ou à l'un des excipients,
- Antécédents d'allergie aux prostaglandines
- Grossesse non confirmée biologiquement ou par échographie
- Suspicion de grossesse extra-utérine (GEU).
- Grossesse de 49 jours d'aménorrhée et plus.

Contre-indications à l'initiation d'un traitement par Mifégyne

- Insuffisance surrénale chronique
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- Asthme sévère, non contrôlé par le traitement
- Porphyrie héréditaire
- Grossesse non confirmée par échographie ou biologiquement
- Grossesse de plus de 63 jours d'aménorrhée
- Suspicion de grossesse extra-utérine
- Contre-indication à l'analogue de prostaglandine utilisé.

Effets indésirables

Les effets indésirables les plus fréquents sont :

- Effets indésirables digestifs (nausées, vomissements, diarrhées), fièvre, frissons.
- Des saignements d'une abondance et durée variables sont attendus et peuvent durer jusqu'à 15 jours.
- Des douleurs pelviennes (contractions, crampes) d'une intensité variable sont également attendus et nécessitent souvent le recours à des antalgiques.

Conditions de prescription et de délivrance

Dans le cadre de cette RTU, la mifépristone et le misoprostol sont soumis à prescription médicale (« Liste I ») et réservé à l'usage professionnel.

Ils ne peuvent donc être délivrés en officine qu'aux médecins, sur présentation d'une commande à usage professionnel.

 CHU REIMS POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 7 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

Définition et prise en charge des rétentions trophoblastiques

Une rétention intra-utérine se définit par la persistance de matériel intra-utérin trophoblastique sur une épaisseur ≥ 20 mm dans le fond de la cavité utérine (indépendante de la prise ou non du Doppler) lors de l'échographie de contrôle de la vacuité utérine.

Lors du contrôle échographique de la vacuité utérine, si la patiente présente une rétention intra-utérine sans saignement actif hémorragique, un contrôle échographique doit lui être proposé après ses prochaines règles.

Si la rétention persiste après ses règles, il est possible de proposer à la patiente :

- **Une attitude expectative** avec recontrôle à 3 mois.
- La réalisation d'un « **curetage chimique** » par prise d'une contraception orale oestro-progestative (en l'absence de contre-indications) de deuxième génération mini-dosée (*exemple : Leeloo : éthinylestradiol 0,02 mg et lévonorgestrel 0,1 mg*) pour une durée d'un à trois cycles avec contrôle de la vacuité utérine ensuite.
- La réalisation d'une hystéroscopie pour réséquer sélectivement cette rétention.

Dans le cas particulier d'une patiente consultant aux urgences gynécologiques pour une rétention avec saignements de moyenne à forte abondance, il paraît légitime de lui proposer **une cure de Misoprostol complémentaire ou une aspiration en urgence** en fonction du contexte, du tableau, de l'avis de la patiente et de l'appréciation de l'équipe prenant en charge la patiente.

2^{ème} situation : Patiente souhaitant une prise en charge en Hospitalisation de Jour

1) L'interne doit **appeler impérativement** pour connaître la disponibilité/programmer l'HDJ :

- L'IDE de programmation au 18178 ou au 19032

Ou

- L'IDE d'HDJ au 18184

➔ Soit l'HDJ peut se faire 48h après la consultation aux urgences

➔ Soit l'HDJ est décalée de la consultation des urgences (absence de place en HDJ, désidératas de la patiente)

Si l'hôpital de jour fermé : Créer quand même le dossier blanc pour mise en fil d'attente

	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 8 / 14	
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES		

2) Dans DIAMM

- Sortie CS gyn ou obst : 5.2 Grossesse arrêtée, PEC médicale en HDJ
- Remplir Grossesse arrêtée à ... SA
- Prescription post HDJ (Paracétamol, spasfon, kétoprofène) à imprimer

Remettre à la patiente le dossier spécifique (dossier que la patiente devra toujours ramener avec elle) :

- CR des urgences (cliquer sur document lié en bas à gauche) + Echographies
- Prescrire un **AT** à la patiente d'une durée de 7 jours. CERFA AT sans carence S3118 (Cf annexes)
- Ordo post HDJ
- Livret d'information patiente
- Copie carte de groupe
- Document personne de confiance

Remplir un dossier blanc qui contiendra :

- Les prescriptions pour l'HDJ signées
- ➔ Le déposer dans une bannette aux urgences

Si la patiente est hospitalisée 48h après la consultation des urgences, faire prendre à la patiente le comprimé de Mifegyne aux urgences

Mais ATTENTION bien rappeler à la patiente que si l'HDJ est décalée, elle devra revenir 36-48h avant son hospitalisation dans le bureau des IDE d'HDJ pour venir prendre le comprimé de Mifépristone.

Ne pas oublier de prescrire **un contrôle à J7 de vacuité utérine** qui sera réalisé aux urgences gynécologiques.

Lors de ce RDV de contrôle une **nouvelle consultation** doit être proposée à la patiente, afin de répondre à ses questions, reprendre avec elle ce qu'elle vient de traverser, discuter de la suite, et proposer un bilan complémentaire dans le cadre des grossesses arrêtées à répétition

DIAMM, Consultation, Dr Achèche M.

La patiente peut aussi prendre RDV ultérieurement en appelant le secrétariat au 03.81.21.81.20

 POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 9 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

Pour l'équipe d'HDJ :

- Possibilité d'administrer un 3^{ème} comprimé de Misoprostol à 16h
- 
Ne pas dépasser une dose totale de 1200 µg en 24h (soit 3 doses de 400 µg)
- Patiente laissée à jeun le temps de l'expulsion
- Sortie seule d'HDJ autorisée si score de CHUNG supérieur ou égal à 9

3) Traitement chirurgical

Il s'agit de l'aspiration obstétricale qui se réalise au bloc opératoire sous anesthésie le plus souvent générale. Il est indiqué en cas de *refus du traitement médical, en cas de contre-indication au traitement par Mifépristone ou Misoprostol, en cas de risque hémorragique et systématiquement après 11 SA*

Pour que la patiente soit prise en charge par le service d'Hôpital de Jour de Gynécologie, il faut impérativement à la fin de votre consultation :

- *Sortie Cs gynec ou obst* : **5.3 Grossesse arrêtée, PEC chirurgicale**
- *Titre inter* : **Curetage Obstétrical pour grossesse arrêtée à SA** (Préciser si Mole, anapath, échec Misoone...)
- *Capacité de vie OMS* : **0. Activité ext normale sans restriction**
- *TTT particulier signalé*
- *ATCD particulier signalé, Remplir les Allergies*
- *Consignes pré hospit*
- *Poids/ Taille*
- *UACA patiente debout* : **OUI**
- *UACA prescription pré op* : **MISOONE/Ibuprofène/Dafalgan (5H30 le jour de la chir)**
- *UACA prescription post op* : **Paracétamol/Spasfon/Kétoprofène**
- *Echo endo...*



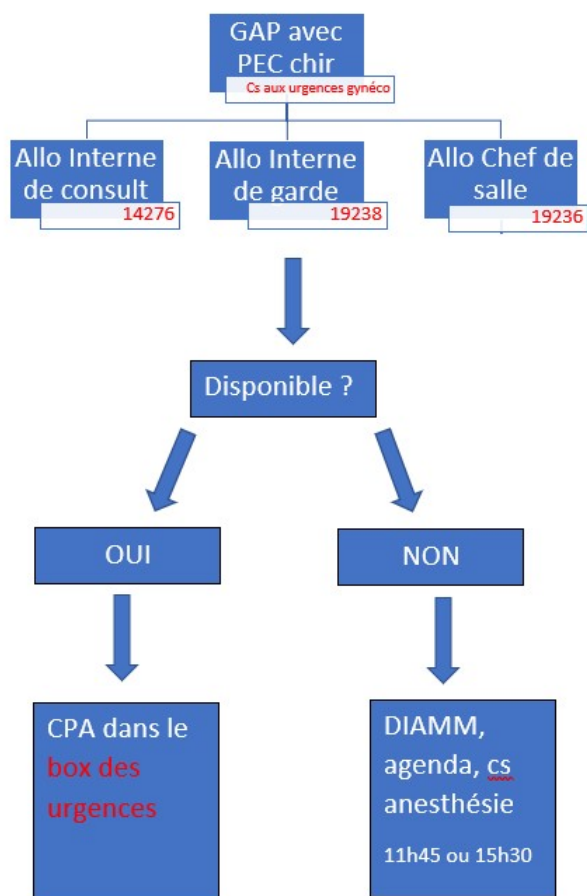
Le bilan bio pré op sera dorénavant prescrit par l'équipe d'anesthésie

CHU RESANCON POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 10 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

sortie Cs gyn. ou obst..	Grossesse arrêtée, PEC chirurgicale
	PROGRAMMATION PEC THERAP.
intervention programmée.	non
degré urgence intervention.	urgence relative
durée prévue interv. (min).	20 min.
info pré-interv orale écrite.	orale : Bénéfice/Risque expliqué ce jour
traitement particulier signalé.	Non, pas de traitement particulier à signaler au bloc
ATCD part. à signaler au bloc.	Aucun ATCD à signaler au bloc
consignes pré-hospit.	.
post-op.: envisager/prévoir.	retour à domicile
UACA patiente debout.	oui
UACA prescription pré-op.	MISOONE 400 microg Cpr séc Plq/1 : 1 cp per os à 5h30 le matin de l'intervention
2 UACA prescription pré-op.	IBUPROFENE RPG 400mg cp pellic : B/30 (ibuprofène): 2 cp à 5h30 le matin de l'intervention
3 UACA prescription pré-op.	DAFALGAN 1g cp pellic : B/8 (paracétamol): 1 cp à 5h30 le matin de l'intervention
UACA prescription post-op.	PARACETAMOL 1g per os : 1 cp toutes les 8 heures si douleurs - QSP 5 jours
2 UACA prescription post-op.	KETOPROFENE LP 100 mg per os : 1 cp matin et soir au moment des repas (en dehors de contre-indication) - QSP 4 jours
3 UACA prescription post-op.	SPASFON cp : 2 à 6 cp par jour - QSP 5 jours

Si le curetage obstétrical doit être prise en charge en urgence, le stipuler et voir avec le sénior pour une date au bloc opératoire.

Demander une consultation auprès de l'anesthésiste



→ Lieu si consultation programmée dans DIAMM : bureau au +1 en HDJ

→ Spécifier GAP sur la prise de RDV

	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002 Version 03 Page 11 / 14
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	

Remplir un dossier blanc qui contiendra :

- Les prescriptions pour l'HDJ signées
- La CPA si réalisée

Le dossier blanc est soit remis à la patiente qui le donnera à Nadine ou déposé dans une bannette aux urgences

Remettre à la patiente le dossier spécifique (dossier que la patiente devra toujours ramener avec elle):

- CR des urgences (cliquer sur document lié en bas à gauche) + Edité
- Prescrire un **AT** à la patiente d'une durée de 7 jours.
CERFA AT sans carence S3118 (Cf annexes)
- **Le Misoprostol** sera systématiquement donné à la patiente aux urgences (1 comprimé)
- Imprimer les ordos pré et post op
- Livret d'information patiente
- La fiche de communication chirurgien-anesthésiste remplie (*Cf annexes*)
- Le document sur la personne de confiance
- Une copie de la carte de groupe

Joindre l'IDE de programmation au 18178 ou au 19032

Adresser la patiente en HDJ de Gynécologie pour finalisation du dossier et planification du geste

Si personne de joignable, la patiente rentre à domicile et sera rappelée sous 72h pour programmation.

CHU RESANCON POLE PMF	GROSSESSE ARRÊTÉE PRÉCOCE < 14 SA		090 URG 210 PT02 002
	PROTOCOLE	URGENCES GYNECOLOGIQUES	Version 03 Page 12 / 14

Annexes : Fiche communication chir/anesth

Intervention envisagée: Curetage obstétricale	
Indication opératoire : Grossesse arrêtée à ... SA	
Lieu d'hospitalisation souhaitée: Chir Gynéco Ambulatoire(chir)	
Durée prévisible :	20 min.
Notion d'urgence :	urgence relative
ATCD part. à signaler au bloc:	RAS
Traitements particuliers à signaler: Aucun	
Allergies :	
Type d'anesthésie souhaitée :	☐ ALR ☒ AG ☐ MIT ☐ Autre :
Intervention hémorragique :	☒ Oui ☐ Non
Position opératoire :	☐ Dorsale ☒ Gynécologique ☐ Autre

Questionnaire HEMSTOP de dépistage du risque hémorragique lié au patient

Les items suivants peuvent évoquer la possibilité d'un trouble de l'hémostase	NON *	OUI*	situation jamais rencontrée*
1. Avez-vous déjà consulté un médecin ou reçu un traitement pour un saignement prolongé ou inhabituel par exemple un saignement de nez ou une petite coupure ?			
2. Avez-vous tendance à faire des bleus de plus de 2 cm ou des hématomes importants, sans choc ou traumatisme ou bien après un choc ou un traumatisme sans importance ?			
3. Avez-vous reconsulté votre dentiste pour saignement après une extraction dentaire ?			
4. Avez-vous saigné de manière anormale après une intervention chirurgicale par exemple opération pour les végétations ou les amygdales ou après une circoncision ?			
5. Y a-t-il des membres de votre famille proche suivis pour une maladie de la coagulation qui est responsable de saignements importants par exemple maladie de Willebrand, hémophilie ?			
6. POUR LES FEMMES : a) Avez-vous consulté un médecin ou reçu un traitement pour des règles trop abondantes par exemple contraception orale (« pilule ») traitement par fer, médicament pour coaguler le sang comme l'Exacyl...?			
b) Avez-vous saigné de façon anormale après un accouchement ?			
Score établi sur le nombre de <u>OUI</u> obtenus sur ces <u>6</u> questions			